

掌法七十二格之手诊理论特点研究

王若冲¹, 刘雷蕾¹, 高冉¹, 贾博涵¹, 唐嘉雯², 张亚鹏¹, 祝广钦¹, 马淑然¹

(¹北京中医药大学中医学院, 北京 102488; ²北京中医药大学针灸推拿学院, 北京 102488)

摘要: 手诊是通过诊查手部信息进行疾病诊断的方法, 掌法七十二格是唐代后流传的一系列手图, 是手诊与九宫八卦的第一次结合, 也是手诊九宫八卦学说的理论渊源之一。文章以中医学整体观念为切入点, 从手诊分区、色泽、形态及纹路4个维度探析掌法七十二格的手诊理论特点与学术思想, 并将掌法七十二格中部分社会化描述与人体生理、病理相结合进行诠释, 从生物-心理-社会医学模式进行系统解读, 以期入手诊法的研究提供新思路。

关键词: 手诊; 掌法七十二格; 九宫八卦; 手相; 生物-心理-社会医学模式

基金资助: 国家自然科学基金青年科学基金项目(No.82104706), 北京中医药大学大学生创新资助项目(No.20220941003)

Study on the theoretical characteristics of hand diagnosis in the seventy-two cases of palm diagram

WANG Ruo-chong¹, LIU Lei-lei¹, GAO Ran¹, JIA Bo-han¹, TANG Jia-wen², ZHANG Ya-peng¹, ZHU Guang-qin¹, MA Shu-ran¹

(¹School of Traditional Chinese Medicine, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 102488, China; ²School of Acupuncture-Moxibustion and Tuina, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 102488, China)

Abstract: Hand diagnosis is a method of diagnosing diseases by examining hand information. The seventy-two cases of palm diagram is a series of hand diagrams circulated after Tang Dynasty, which is the first combination of hand diagnosis and Nine Palaces and the Eight Diagrams, and also one of the theoretical sources of the theory of Nine Palaces and the Eight Diagrams. Based on the overall concept of traditional Chinese medicine, this paper analyzes the characteristics and academic thoughts of hand diagnosis contained in the seventy-two cases of palm diagram from the four dimensions of hand diagnosis division, color, shape and grain, and makes a comprehensive interpretation after combining the social description of the seventy-two cases of palm diagram with the state of medical physiology and pathology. This paper makes a systematic interpretation of biological-psychological-social medical models, in order to provide new ideas for the study of hand diagnosis.

Key words: Hand diagnosis; The seventy-two cases of palm diagram; Nine Palaces and the Eight Diagrams; Palmistry; Biological-psychological-social medical model

Funding: Young Scientists Fund of the National Natural Science Foundation of China (No.82104706), College Students' Innovative Program of Beijing University of Chinese Medicine (No.20220941003)

手诊法^[1]是通过观察手部纹路、色泽、形态等信息的中医特色诊法。现代研究表明, 手诊不仅可用于疾病诊断, 还可应用于疾病预测, 如肿瘤、糖尿病、冠心病等疾病均会在早期时在手部出现异常征象^[2-3], 而这些征象的出现往往早于临床症状的发生, 因此我们可通过手诊达到早期诊断或未病先防的目的。手诊法在我国历史悠久, 早在《黄帝内经》

中即有将局部手征与身体疾病相关联的手诊记载, 如《灵枢·经脉》曰: “掌中热者, 腹中热; 掌中寒者, 腹中寒”。掌法七十二格是唐代后流传的一系列手部掌图, 共有七十二幅图, 因此也被称为七十二手图。掌法七十二格起初流传于民间, 宋代学者陈抟将其总结并出书立著^[4], 起初掌法七十二格主要通过掌部信息对人的身体进行社会化诠释, 重视人的

社会活动与手部征象的相关性^[5]。自明清时期后,其内容逐渐与医学相融合,1949年后亦有研究者对掌法七十二格进行研究,学者们以科学严谨的态度产出了部分研究成果。本团队考证发现,掌法七十二格对手诊法的形成有较大的影响,时至今日现代手诊法在纹路命名、理论思想、诊断特点等方面均对掌法七十二格有所继承。然而,无论是在民间认识、临床实践还是医学研究中,掌法七十二格常被神秘化,导致其相关研究较少,未形成系统论述。因此,本文基于分区、色泽、形态、纹路4个维度探析掌法七十二格中蕴含的手诊特点与学术思想,并从生物-心理-社会医学模式进行解读,探讨其对后世手诊学的影响。

分区

《望诊遵经》云:“大凡望诊,先分部位,后观气色”,诊法中“位”可定位脏腑诊断信息。手诊将手部划分区域来代表身体各部位而达到明确病位的目的。掌法七十二格将手部按照九宫八卦之方位进行分区,将掌部自尺侧起分为乾宫、坎宫、艮宫、震宫、巽宫、离宫、坤宫、兑宫及明堂(中宫)共九宫,进而以卦象阴阳五行为基础属性进而推演、论述各宫与相应脏腑关系,掌法七十二格分区见图1。据考证,掌法七十二格是九宫八卦与手掌分区的首次结合,也是手诊九宫八卦学说的理论渊源之一^[6]。此后,医者根据此分区法,逐渐创建了手诊九宫八卦学说,如明代杨继洲所著的《针灸大成》中即载有男子阳掌八卦图和女子阴掌八卦图^[7]。此外,掌法七十二格内容还流传至海外,如东亚地区及欧洲部分地区就吸收其九宫八卦思想,创立了手诊星丘分区法。九宫八卦分区图与星丘分区之比较可见图2,由图可见两者区别仅是星丘分区法将离宫一分为二,即:土星丘与太阳丘。

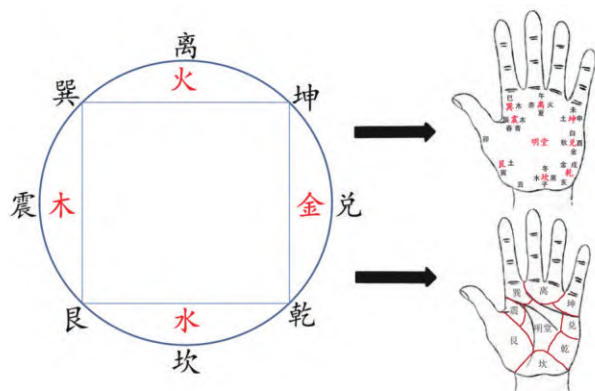


图1 掌法七十二格分区

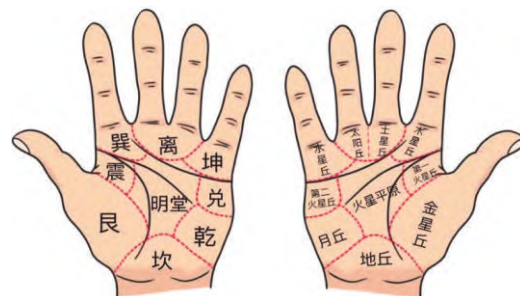


图2 九宫八卦分区图(左)与星丘分区(右)图

色泽

掌法七十二格十分注重掌部色泽状态,其中包含了主色、客色与善色、恶色的诊断思想。不论是宋代陈抟、明代袁珙还是清代倪岳均在其著作中将手掌色相关的“四季纹”序为掌法七十二格之首,《玉管照神局》记载:“春青夏赤秋宜白,四季之中黑喜冬。秋赤冬黄春见白,夏间逢黑总为凶”,言明掌色会随着四季交替发生变化,其中掌色与季节相应为善,如秋季掌色见白;掌色与四时颜色相克则为恶,如秋季掌色见红。

掌法七十二格还言明了常人掌色应以红润为宜,提示脏气充盈,脏腑功能正常,如“手红色润是多能”,这与现代学界认为健康之人的掌色应呈淡红色或粉红色、光泽明润的叙述相一致。此外,掌法七十二格中还记载部分恶色,如在“玉柱线”中记载的“干黄不好”,“劫杀纹”中记载的“干黄不成”等,研究表明,在肝癌晚期、黄疸、肝炎及动脉硬化等疾病出现时掌色会干枯泛黄^[8]。最后,掌法七十二格也记载当掌区红润程度超出正常范围,提示身体处于病理状态,如各掌区过于红润且丰满时需预防高脂血症^[9],掌法七十二格色泽代表论述与意义见表1。

表1 掌法七十二格色泽代表论述与意义

掌格名称	论述内容	掌格相关记载	具体含义
四季纹	四时掌色	春青夏赤秋宜白,四季之中黑喜冬,秋赤冬黄春见白,夏间逢黑总为凶	掌色与季节相应为善,掌色与季节相克为恶
四直纹	掌之善色	更宜红润色,中年不用愁	红润为宜
玉柱线	掌之恶色	需学堂相副,干黄不好	干黄不好

注:掌格即掌法七十二格。下表同。

掌法七十二格包含了中医色诊的思想,尤其注重掌色应随四时而变。此外,还包含了大量善色与恶色的内容,为后世手诊法色诊的发展提供依据。

形态

掌法七十二格的形态论述主要集中于掌心九宫,其主要内容可概括为三部分:其一,掌法七十二格认为掌区内九宫除明堂外,均应饱满丰盈,提示各宫所代表脏腑精气充足、机能正常。如“金龟纹”的记载:“兑宫西岳起隆隆,纹似金龟势象雄。遐寿定须过百岁,居家金定更雍容”,兑为金,主肺与大肠,年老之人兑宫丰满如龟,表明呼吸、消化系统健康,因此易长寿。其二,若各宫低陷则提示此宫所代表脏腑精气不足、机能异常,如“坎宫低陷纹冲乱,曾遇风波水患侵”,坎为水,主肾,坎宫低陷且纹路杂乱,提示肾气不足、肾虚水泛;对于巽宫的描述亦如此,“低陷更兼纹又破,纵然富贵也癫狂”,巽为木,主肝胆,巽宫低陷提示肝胆精气不足、纹路断裂则为患病之象,在临床中多为精神类疾病的患病纹路^[10]。其三,若各宫隆起程度超过了正常范围,表明相应脏腑功能过于亢进,此时需与色泽共同判断,如“三峰纹”的记载:“三峰堆起巽离坤,肉满高如枣样圆。光泽更加红润色,家中金玉有良田”,现代多项研究表明,掌中巽宫、离宫、坤宫的过度凸起伴见红色可作

为诊断高脂血症的依据之一^[11-12]。古时,百姓大多无法解决温饱问题且平均寿命较短,更不易患高脂血症这样的“富贵病”,所以在很长时间内“三峰”是社会地位高、家族财产丰厚的表现,掌法七十二格形态代表论述与意义可见表2。

表2 掌法七十二格形态代表论述与意义			
掌格名称	论述内容	掌格相关记载	生理/病理含义
金龟纹	掌区丰盈	兑宫西岳起隆隆,纹似金龟势象雄	脏腑精气充足、功能正常
巽宫纹	掌区低陷	低陷更兼纹又破,纵然富贵也癫狂	脏腑精气不足、功能异常
三峰纹	掌区过于凸起	三峰堆起巽离坤,肉满高如枣样圆	脏腑功能过亢、功能异常

掌法七十二格记载了大量形态诊断的内容,其核心思想即根据掌部各区的盈亏程度,从而论述身体脏腑机能,现代手诊理论也继承了掌法七十二格中掌部形态的三方面学术思想^[8],这也是手诊九宫八卦学说的诊断特点之一^[6]。

纹路

纹路诊断是手诊法中的重要组成与核心部分^[13]。

表3 “十四条常见线”与掌法七十二格相关论述与意义

掌纹标准(西方手诊名称)	掌格名称	掌格相关记载	纹路形态	生理/病理意义
1线(感情线)	天纹	上画应天,象君,象夫,定其贵贱	起于手尺侧小指下方,以弧形向桡侧伸展止于中指、食指中缝下处	生理线,与视听神经、呼吸系统、循环系统相关
2线(智慧线)	人纹	中画应人,象贤,象愚,辨其贫富	起于食指根与拇指根中点,以弧形向尺侧伸展,止于无名指与小指中缝下处	生理线,与循环系统、智力及外伤相关
3线(生命线)	地纹	下画应地,象臣,象母,主其寿夭	起于食指根与拇指根中点,以弧形向掌根伸展,止于掌根中点	生理线,与人体质、精力及总体健康状况相关
5线(成功线)	玉柱线	玉柱线从掌直去,为人胆智必聪明	起于手掌下方坎宫,直向上通过掌心,向中指延伸	生理线,无此线亦正常,若过粗过长,多提示心脑血管疾病
6线(干扰纹)	笔阵纹	笔阵纹生阵阵多,文章德行胜邹轲	横切各主线或副线的多条直纹,位置不固定	病理线,机体功能异常,与出现部位相关
7线(太阳线)	高扶纹	高扶纹出无名指,胆气高强难比	无名指下的1~3条竖纹	病理线,与与循环系统疾病相关,2条提示血压异常,3条及以上提示神经衰弱
8线(放纵线)	拜相纹	拜相纹从乾位寻,其纹好似玉腰琴	乾宫出现短横纹,可稍斜	病理线,1条提示生活不规律,内分泌失调;2~3条提示高血糖症或糖尿病
11线(性线)	妻宫纹	妻宫只有一重纹,没有妻奴及弟兄。若有两纹并四画,许君后续好儿孙	起于手掌尺侧小拇指根部,3条横线,中间1条较长,两侧2条较短	生理线,与生殖功能相关,健康者有3条提示生殖功能正常;无者或仅1条多提示女子发育不良不孕,男子少精、无精、阳痿
12线(肝病线)	跳夜纹	桃花杀现爱奢华,即爱贪杯又好花	起于1线与小指根中部,向无名指下方伸展	病理线,提示肝脏解毒代谢能力弱,常与酗酒相关
13线(悉尼线)	亡神纹	手中横直号亡神,更防性命险难平	2线变异,平直延伸到手掌尺部	病理线,与癌症相关

掌法七十二格对手诊纹路诊断贡献颇丰。本团队考证发现,掌法七十二格中与纹路相关的手图共有66幅图,占比超过九成。目前,学界认可的掌纹标准化“十四条常见线”掌法七十二格中记载有10条;“八种异常纹”掌法七十二格中记载有7种,其中诸多纹路命名也延续至今,如“天纹”“人纹”“地纹”等。

1. 掌法七十二格中常见线的记述 掌法七十二格共记载了10条常见线,部分掌纹所代表的生理、病理意义的记载与目前研究相一致,如三大主纹的记载:“三才纹上得分明,时运平生可得平。主命兴财俱有气,一纹冲破便无情”,言明三才纹应清晰深刻,纹路完整无断纹,提示人体精气充足、身体健康,此论述与现代手诊法中三大主线内容相吻合;再如,对于人纹之论述“中画应人,象贤,象愚”,与2线可反映人体神经、精神功能及智力水平的研究相符;地纹的描述“下画应地,主其寿夭也”,也与3线可反映人体的总体健康状态的研究相符。其中,部分纹路偏向于社会化诠释,但仍可依据现代医学进行解释,如“手中横直号亡神,更防性命险难平”,“亡神纹”正是“十四条常见线”(图3)中的第13线,西方又名悉尼线。现代研究表明,悉尼线是诊断癌症的手部重要征象,且家族遗传倾向较强。这也解释了为什么古人称之为“丧命之象”,并认为此纹路会影响父母及子女。“十四条常见线”与掌法七十二格相关论述与意义见表3。

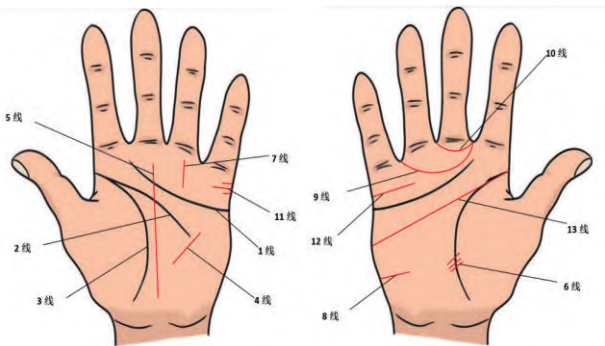


图3 十四条常见线

2. 掌法七十二格中异常纹的记述 掌法七十二格记载了除星状纹外的常见异常纹路。研究表明临床中星状纹的出现频率较少,且星状纹可由其他7种异常纹路混合组成^[14],这或许是掌法七十二格没有记载该纹路的原因。掌法七十二格中对于异常纹路的记述从病理角度的论述较少,多集中于社会化的

诠释。近20年来有研究者如刘剑锋^[1]、王晨霞^[15]、王鸿^[16]等从医学的角度对掌法七十二格进行阐述。本团队在前人的基础上开展研究,将其社会表象与人体病理状态相联系研究探讨并进行总结,发现其社会化诠释的本质实为身体健康状态的变化。例如,掌法七十二格中的“兵符纹”即为方形纹,古时为掌管兵符的将军之象。现代研究表明,方形纹多提示由手术或外伤引起的疤痕或因各种因素造成的体内瘀血与粘连^[17]。古代将士出征易受刀剑之外伤,且容易体内形成瘀血与粘连,因此将其与将士之象相结合就不足为奇了。异常纹与掌法七十二格相关论述与意义见表4。

表4 异常纹与掌法七十二格相关论述与意义

掌纹标准命名	掌格名称	掌格相关记载	病理意义
十字纹	朱雀纹	朱雀纹生向掌来,一生终是惹官非。若有叉纹犹自可,最忌两头口又开	提示疾病病情较轻,处于早期,或病情好转
米字纹	金花纹	纹带金花印立身,此生富贵不忧贫	提示脏腑功能弱,气滞血瘀,病程较长,病势较重
	六花纹	若人有此六花纹,他日身沾雨露恩	
三角纹	美禄纹	美禄纹如三角形,偏宜三角带横生	提示冠心病隐患,病情介于米字纹与十字纹之间,有向米字纹发展的趋势
岛纹	柳叶纹	纹如柳叶贯穿河,巷陌风花度岁月;暮雨朝云心更喜,中年因此患沉痾	提示增生或炎症肿块,若岛纹过大代表相应的脏器虚弱
	月角阴纹	月角阴纹出兑来,莫教色上惹官灾	
环形纹	宝晕纹	宝晕纹奇异形相	提示与重大外伤及手术相关
	车轮纹	此纹圆满主车轮	
井字纹	玉井纹	一井纹为福德人,二三重井玉梯名;此人必定能富贵,出入朝中佐圣明	提示慢性炎症,发展缓慢,无器质性病变
方形纹	兵符纹	兵符纹现掌中央,年少登科仕路长。节钺应全权要职,震戎边卫拥旌幢	提示手术或外伤引起的疤痕或因各种因素造成的体内瘀血与粘连

纹路诊断一直都是手诊中的热点,西方专门设立皮肤纹理学从而研究纹路与健康的关系^[18]。掌法七十二格之记述九成以上与纹路相关,也表明对于纹路诊断的重视。现代手诊法中不仅继承了掌法

七十二格中纹路形态的描述、还继承了纹路命名、诊断思路等需多方面的内容。

生物-心理-社会医学模式与掌法七十二格

19世纪时,受近代自然科学还原论的影响,医学把人比作可拆卸的“机器”,认为疾病的发生均为生物性因素引起的躯体疾病,并提出了生物医学模式。但随着微观的结构研究原理越来越清晰,人却逐渐从心理、社会的有机联系中被分离出去。因此,1977年《Science》杂志批判了生物医学模式,提出了生物-心理-社会医学模式,即“健康就是身体、精神和社会方面的完好状态,而不仅指没有疾病和虚弱”,强调除生物源因素外,心理因素与社会环境因素等亦可影响人体健康。这与中医重视人与社会环境相适应的整体观不谋而和,在掌法七十二格中就存在着大量生物-心理-社会医学模式的相关思想,注重心理、社会等因素对机体带来的影响。

1. 掌法七十二格中社会因素 “拜相纹从乾位寻,其纹好似玉腰琴。性情敦厚文章异,常得君王眷顾深”,言明社会地位高,掌中乾宫会出现多条如琴弦的横纹,即“拜相纹”。现代手诊法中,乾宫出现一条横纹为“十四条常见线”的第8线,多提示生活不规律,可由长期熬夜、体力过度消耗或饮酒等原因导致,因此8线也被称为“放纵线”,多条8线则是“拜相纹”。现代医学表明,“拜相纹”是高血糖症及糖尿病的典型特征^[19]。在古代,百姓生活质量较低、饮食质量较差,因此患糖尿病的几率较少。社会地位高之人多衣食无忧,过食肥甘厚味,但生活不规律且缺乏运动,所以此类人极易出现内分泌系统紊乱,导致血糖升高甚至糖尿病的情况。上文形态部分中论述的“三峰纹”亦是如此,言明由于生活条件好、饮食营养过盛的社会环境背景诱发高脂血症,进而在手部出现征象。

掌法七十二格中十分重视社会因素对人体的影响,“拜相纹”“三峰纹”等即是由于社会因素导致机体功能异常,进而在掌中表现出异常征象。

2. 掌法七十二格中心理因素 掌法七十二格记载着大量心理因素与精神因素对人体的影响,现代研究表明,掌中各区域纹路杂乱提示相关脏腑机能异常^[8],如“离纹冲破多劳碌”,离为火主心,当人长时间处于高度紧张的精神状态下或长期劳心耗神时,会导致心的机能下降,从而心气虚或心血虚,此时离宫则会出现纹路断裂,即“离纹冲破”,因此不良

的心理因素和精神状态会导致心主血脉功能与心主神智的功能出现异常,并在掌中表现出相关纹路;此外,“高扶纹”的论述易如此,“高扶纹”是离宫无名指下出现的多条竖纹,是掌纹标准化中“十四条常见线”的第7线,为病理线,与血压、心脏功能相关,2条提示血压异常,3条及以上提示神经衰弱。掌法七十二格中记载该纹多提示心高气傲、胆气高强,此类人往往抱负太高而处于过度劳累奋斗、精神紧张的心理状态下,思虑过度而影响心主神志的功能,出现血压不稳定甚则神经衰弱的表现。

3. 验案举隅 患者某,女,18岁,2022年2月22日就诊。手诊法诊断:患者指缝稍大呈乌贼骨样,十指指节有竹节纹倾向,结合震、离两宫纹路杂乱且多,人纹过于平折,提示神经衰弱与失眠,并处于思虑过度或高度紧张状态;此外,人纹与地纹重叠范围较长,大鱼际出现青筋,明堂心区出现方形纹,提示患者心肝血虚。见图4。问诊得知:患者自幼内向,思虑较多,目前正处于高三阶段。上学期期末考试名次不佳,导致压力较大常担心高考失利,平日沉默寡言。近日,不仅出现了持续性疲劳、心悸、视力下降、失眠、多梦健忘等心肝血虚症状,还出现了情志抑郁、善太息、月事两月不至等肝郁气滞症状。

掌法七十二格中蕴含着大量生物-心理-社会医学模式的思想,十分注重社会因素与心理因素对机体的影响。现代手诊法继承了此观念,该患者体现了高三考生的社会背景因素对其的影响,还体现了处于压力及精神紧张下心理因素的影响。由此可见,手诊在临床中对于心理、社会等因素十分重视,与生物-心理-社会医学模式认为的“健康就是身体、精神和社



图4 病例手诊图

会方面的完好状态,而不仅指没有疾病和虚弱”的思想具有很高的契合度。

小结

手诊不仅在我国具有深厚的历史渊源并存在众多流派,如鱼际络脉诊法、望小儿食指诊法及手诊九宫八卦诊法,在国外,手诊也有千余年的历史并发展出了众多学说,如星丘学说、皮肤纹理学等^[13]。近年来随着中医药传统知识保护挖掘与利用也带动了手诊的溯源研究。掌法七十二格作为手诊的理论渊源之一,其源于民间后渐应用于诊法之中,已成为手诊的重要组成部分。人与社会环境的统一性是中医理论体系特点中的重要观念,中医认为社会环境与心理因素与人的生理、病理及疾病诊治关系密切,正如《素问·疏五过论》曰:“诊有三常,必问贵贱,封君败伤,及欲侯王。故贵脱势,虽不中邪,精神内伤,身必败亡。始富后贫,虽不伤邪,皮焦筋屈,痿痹为挛”,言明心理因素与社会环境在诊病及疾病发生中的重要性。对于掌法七十二格的研究即包含此内容,其不仅通过手部征象对人体的生理、病理展开论述,正符合“近取诸身,四支百体合其度”;而掌法七十二格还可结合社会因素与诊法深度融合,则符合“远取诸物,森罗万象备其工”。此外,从手部对人体、性格及社会等不同纬度的解读也符合中医对于“善诊者”的内在要求,如《素问·举痛论》载:“善言古者,必有合于今;善言人者,必有厌于己”。掌法七十二格中蕴含着大量相关思想,但鲜有研究,仅偶有部分著作提到,研究仍不充分不具体,缺少专题研究。因此,本文从分区、色泽、形态及纹路四个维度探析掌法七十二格中的手诊特点与学术思想,并将部分社会化描述与医学生理、病理状态相结合,从生物-心理-社会医学模式进行综合诠释,以期入手诊法的研究提供新思路。

参考文献

- [1] 刘剑锋.手诊.北京:华龄出版社,1992:48-59
- [2] Mahesha Y,Nagaraju C.Automating the identification and evaluation of the position of axial triradius on palm print:An approach to early detection of congenital heart diseases.Biomedical Engineering:Applications,Basis and Communications,2021,33(2):11-18
- [3] Chakravathy P G,Shirali A,Chowta K N,et al.A handy tool for hypertension prediction:Dermatoglyphics.Indian Heart Journal,2018,70(3):S116-S119
- [4] 故宫博物院.新刊合併官板音义评注渊海子平神相全编:子平集要.海口:海南出版社,2000:228-241
- [5] 安宏,秦培洁,王柳青,等.辨“手诊”“手相”.中国中医基础医学杂志,2021,27(10):1578-1580,1674
- [6] 王若冲,宋月晗,张翼飞,等.手诊九宫八卦学说的理论渊源及诊断特点探讨.中华中医药杂志,2022,37(3):1421-1424
- [7] 明·杨继洲.针灸大成.北京:中国中医药出版社,1997:468-471
- [8] 赵睿霆.“手诊法”在中医诊断学中的理论基础及临床应用研究.成都:成都中医药大学,2012
- [9] 韩学杰,刘大胜,郜亚茹,等.中医手诊三维诊断法的理论渊源及临床应用.中华中医药杂志,2019,34(9):3935-3938
- [10] 孙业恒,余曼华,董毅,等.精神分裂症掌纹特征的病例对照研究.安徽医科大学学报,1998,33(2):33-34
- [11] 任聪.血脂异常的手部特征及其与中医证候、西医分型相关性临床研究.北京:中国中医科学院,2020
- [12] 任聪,刘大胜,郜亚茹,等.韩学杰主任医师手诊辨证经验及高脂血症验案举隅.光明中医,2020,35(11):1632-1634
- [13] 王若冲,李儒婷,马捷,等.手诊分区法之原理探析与诊断应用.世界科学技术-中医药现代化,2021,23(10):3830-3837
- [14] 王晨霞.王晨霞掌纹图典.北京:中医古籍出版社,2012:52
- [15] 王晨霞.现代掌纹诊病图谱.南宁:广西科学技术出版社,2001:15-65
- [16] 王鸿.掌纹与健康.石家庄:河北人民出版社,2006:4-20
- [17] 黄志信.掌纹诊病之理论研究.济南:山东中医药大学,2013
- [18] 吕仪,陈聪,郝一鸣,等.掌纹诊法研究与临床应用的概述与展望.世界科学技术-中医药现代化,2020,22(5):1559-1566
- [19] 杜玲玉珊,魏宁颐,杨梅.手诊在糖尿病诊治中的应用研究概况.中国民族民间医药,2022,31(3):73-76

(收稿日期:2022年11月28日)